



Spinal Astrositomda Kistik Lezyonlar

Cystic Lesions in Spinal Astrocytoma

Ahmet Evlice, Dilek İşcan, Meltem Demirkıran

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Adana, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Spinal, astrositom, kist

Keywords: Spinal, astrocytoma, cyst

Giriş

Astrositom; glial hücrelerin kontrolsüz üremesi sonucu oluşan erişkinlerde epandimomadan sonra en sık gözlenen spinal kord tümörüdür (1). Erkeklerde daha sık olup sırasıyla servikal ve torakal bölgede gözlenir (2,3,4). Yakınmalar genellikle radiküler ağrı ile başlar, ilerleyen dönemde duyu kaybı, motor defisitler, spastisite ve sfinkter kusuru tabloya eklenir (3,5). Bu makalede bacaklarda güçsüzlük yakınması ile başvuran, nöro-görüntüleme yöntemleri ve histopatolojik veriler ışığında anaplastik astrositom saptanan bir olgu sunulmuştur.

On yedi yaşındaki kadın hasta bir yıldan bu yana var olan progresif seyirli bacaklarda güçsüzlük, his kaybı ve idrar inkontinansı yakınmaları ile kliniğe kabul edildi. Nörolojik muayenede; 4/5 düzeyinde paraparezi, alt ekstremitelerde derin tendon reflekslerinde hiperaktivite, L1 altı seviye veren yüzeysel duyu kusuru, alt ekstremitelerde vibrasyon duyusu kaybı, bilateral Babinski refleksi pozitifliği gözlemlendi. Serebral manyetik rezonans görüntüleme (MRG) normal sınırlarda olup spinal MRG incelemesinde T5-9 düzeyinde posterior spinal kord epidural mesafede multipl mikrokistik yapılar, T9-12 düzeyinde kord ödemi ve miyelomalazi bulguları saptandı (Resim 1, 2, 3). Miyelit ön tanısıyla yapılan beyin omurilik sıvısı incelemesinde hücre gözlenmedi, protein 2549 mg/dl, glukoz 71 mg/dl, laktat 9,4 mg/dl, sodyum 135 mEq/l saptandı. Spinal kitle ön tanısı ile beyin cerrahisi kliniğine konsülte edilen olgu opere edildi. Cerrahi materyali histopatolojik inceleme sonucu anaplastik astrositom olarak tanındı ve olgu takibe alındı.

Literatür verileri gözden geçirildiğinde astrositom tanılı olgularda spinal MRG lezyonlarının; bizim olgumuzda olduğu gibi (Resim 1, 2, 3) T1 de hipo ya da izointens, T2 de hiperintens olması beklenmektedir (6). Solid tümörden ayrımı yapılamayan kistik lezyonlar da nadiren gözlenebilir. Bunun nedeni kist içerisindeki sıvının yüksek protein içeriğidir (6,7). Olgumuzda



Resim 1. Spinal manyetik rezonans görüntüleme, T1 sekans, sagittal eksen

Yazışma Adresi/Address for Correspondence: Dr. Ahmet Evlice, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Adana, Türkiye
Tel.: +90 322 338 60 60-3206 E-posta: aevlice@yahoo.com

Geliş Tarihi/Received: 16.12.2015 **Kabul Tarihi/Accepted:** 11.02.2016



Resim 2. Spinal manyetik rezonans görüntüleme, T2 sekans, sagittal eksen

tümörden bağımsız olarak tümörün çevresinde multipl kistik yapılar gözlenmiştir. Literatürde benzer özelliklere sahip herhangi bir olgu bildirilmemiştir. Olgu ilginç nöro-görüntüleme bulgusuna sahip olması nedeniyle okuyucunun bilgisine sunulmuştur.

Etik

Hasta Onayı: Çalışmamıza dahil edilen tüm hastalardan bilgilendirilmiş onam formu alınmıştır.

Hakem Değerlendirmesi: Editörler kurulu dışında olan kişiler tarafından değerlendirilmiştir.

Yazarlık Katkıları

Medikal Uygulama: Ahmet Evlice, Dilek Işcan, Meltem Demirkıran, Konsept: Ahmet Evlice, Dilek Işcan, Meltem Demirkıran, Dizayn: Ahmet Evlice, Dilek Işcan, Meltem Demirkıran, Veri Toplama veya İşleme: Dilek Işcan, Analiz veya Yorumlama: Ahmet Evlice, Dilek Işcan, Meltem Demirkıran, Literatür Arama: Ahmet Evlice, Dilek Işcan, Meltem Demirkıran, Yazan: Ahmet Evlice, Dilek Işcan, Meltem Demirkıran.



Resim 3. Spinal manyetik rezonans görüntüleme, T2 sekans, aksiyel eksen

Çıkar Çatışması: Yazarlar bu makale ile ilgili olarak herhangi bir çıkar çatışması bildirmemiştir.

Finansal Destek: Çalışmamız için hiçbir kurum ya da kişiden finansal destek alınmamıştır.

Kaynaklar

1. Fischer G, Brotchi J, Chignier G, Liard A, Zomosa G, Menei P, Hallacq P: Epidemiology. In: Fischer G, Brotchi J (eds) Intramedullary spinal cord tumors. Thieme, Stuttgart, 1996, pp 9-10.
2. Minehan KJ, Shaw EG, Scheithauer BW, Davis DL, Onofrio BM. Spinal cord astrocytoma: Pathological and treatment considerations. J Neurosurg 1995;83:590-595.
3. Reimer R, Onofrio BM. Astrocytomas of the spinal cord in children and adolescents. J Neurosurg 1985;63:669-675.
4. Epstein F, Epstein N. Surgical management of holocord intramedullary spinal cord astrocytomas in children. J Neurosurg 1981;54:829-832.
5. Fischer G, Brotchi J. Intramedullary spinal cord tumors. Thieme, Stuttgart, 1996, pp 72-81.
6. Osborn AG. Diagnostic neuroradiology. Mosby, St. Louis, 1994, pp 906-914.
7. Horger M, Ritz R, Beschoner R, Fenchel M, Nägele T, Danz S, Ernemann U. Spinal pilocytic astrocytoma: MR imaging findings at first presentation and following surgery. Eur J Radiol 2011;79:389-399.